



**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 334-56-89

E-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109

№ _____

На _____ від _____

Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та обласних державних адміністрацій

Керівникам центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України

Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» (далі - Центр) надсилає для інформації та використання в роботі «Інформаційно-аналітичну довідку про розповсюдженість сальмонел серед людей (хворих та носіїв) та в об'єктах середовища життєдіяльності людини на території України у 2024 році».

При підготовці Інформаційно-аналітичної довідки використані дані з форми галузевої статистичної звітності (ф. 40-здоров) та форми державної статистичної звітності N 2 «Звіт про окремі інфекції і паразитарні захворювання» (річна).

Додаток: зазначене на 22 арк.

Генеральний директор

Михайло РОСАДА

Глушкевич Т. 3345784



№ 04-12/22.1/2679/25 від 30.04.2025
КЕП РОСАДА МИХАЙЛО
ОЛЕКСІЙОВИЧ
5E984D526F82F38F04000000182E4F0135D30F06

ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"
№ 04-12/22.1/2679/25 від 30.04.2025



№22-2278/01-11/1-25 від 30.04.2025



**Державна установа «Центр громадського здоров'я
Міністерства охорони здоров'я України»**

**Інформаційно-аналітична довідка
про розповсюдженість сальмонел серед людей (хворих та
носіїв) та в об'єктах середовища життєдіяльності людини
на території України у 2024 році**

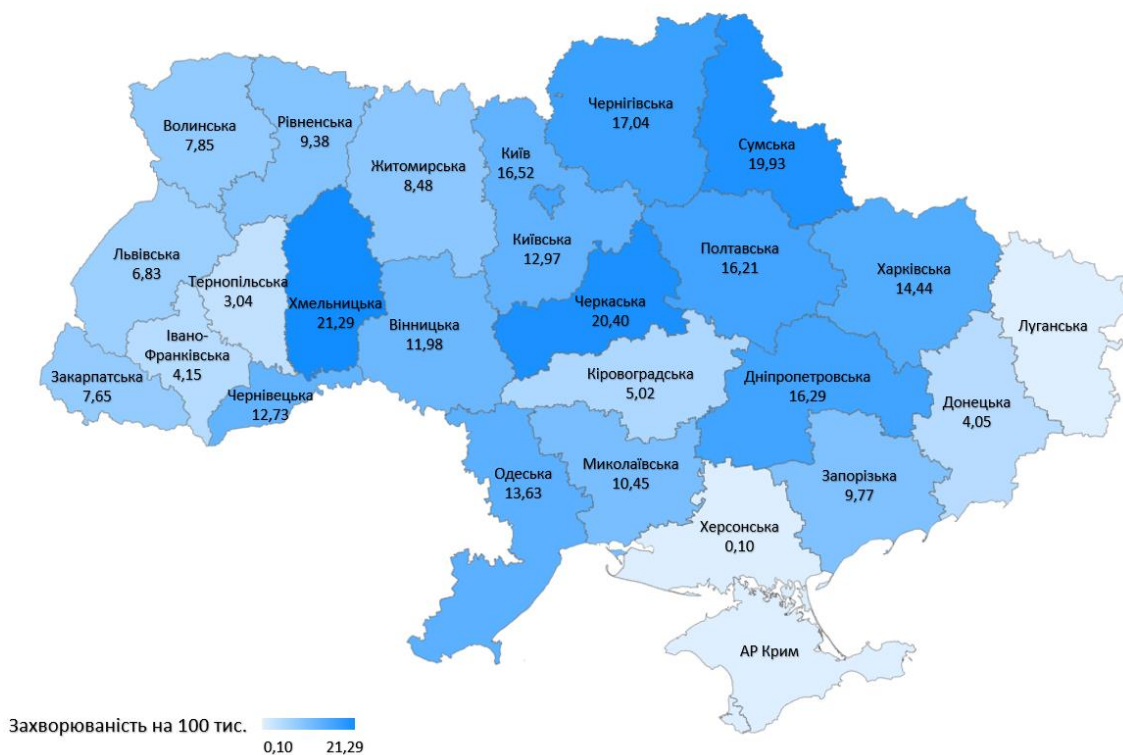
Київ 2025

Епідемія харчових захворювань в багатьох країнах світу, яка спричиняє значні витрати для людей, харчового сектору та економіки, підкреслює незмінну важливість безпеки харчових продуктів. Незважаючи на певний помітний прогрес у харчовій науці та технології, харчові захворювання продовжують мати серйозні наслідки для громадського здоров'я. Імовірність захворіти на харчові захворювання значно зросла за останні 20 років, піддаючи приблизно 25% населення більшому ризику. Одним із найпоширеніших харчових бактеріальних патогенів у всьому світі є *Salmonella* spp, який, як вважається, спричиняє 93,8 мільйонів випадків сальмонельозу щорічно, а також 155 000 летальних випадків.

У всьому світі також зростає занепокоєння щодо зростання захворюваності спричиненої мультирезистентними сальмонелами серед людей, домашніх тварин та інших видів дикої природи, ці штами вперше з'явилися наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років. Це включає стійкість до фторхінолонів і цефалоспоринів третього покоління, двох терапевтично значущих протимікробних препаратів.

Захворюваність в Україні залишилась майже на одному рівні. В 2024 році захворіло на сальмонельози 4406 осіб, Число хворих зменшилось лише на 0,18% в порівнянні з минулим роком (2023 рік – 4414 осіб). Діагноз було підтверджено бактеріологічно у 4359 випадках захворювань (2023 рік – 4301), серологічно у 20 випадках (2023 рік – 40), клінічно, без лабораторного підтвердження, діагноз сальмонельозу був встановлений у 27 випадках (2023 рік – 73).

Захворюваність на сальмонельози по регіонах України за 2024 рік (на 100 тис. населення)

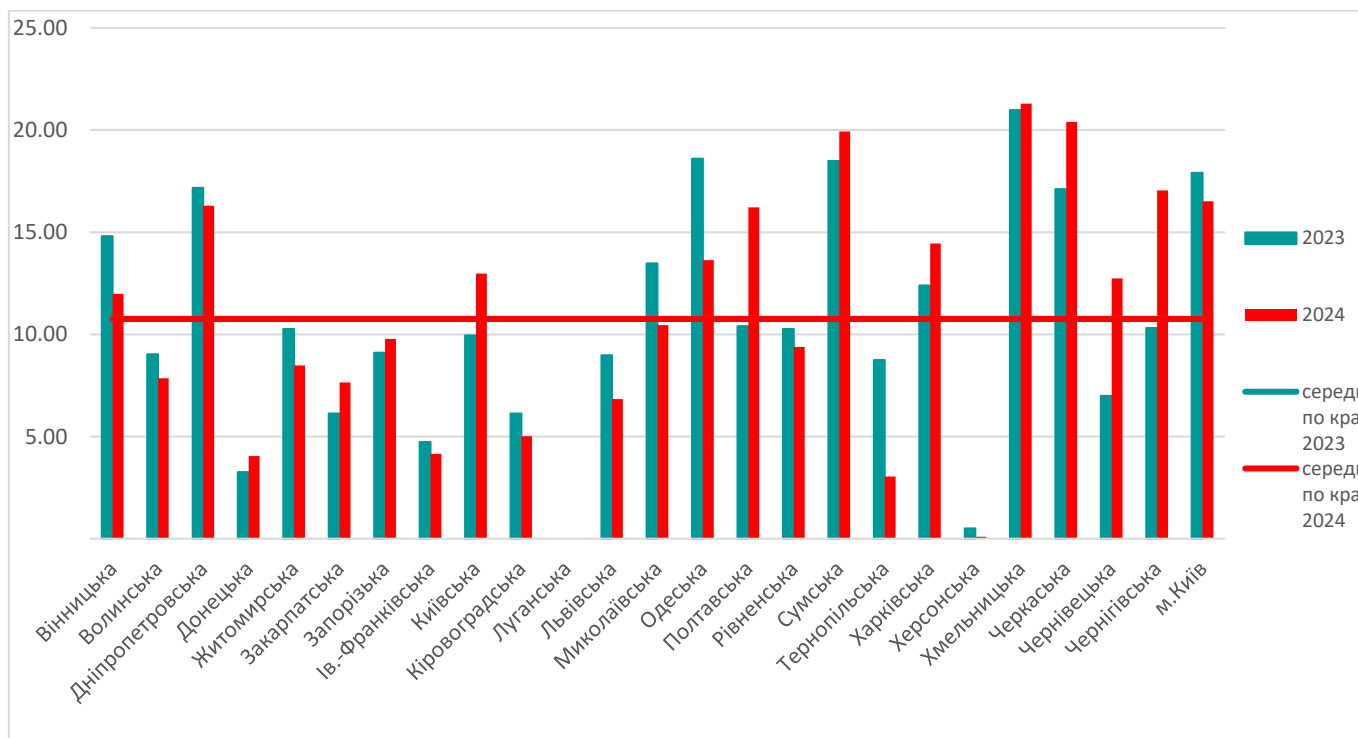


На відміну від попередніх років в 2024 році випадків захворювань на черевний тиф та паратифи не зареєстровано жодного. Захворюваність на інші сальмонельозні інфекції зменшилась на 0,14%.

Середній інтенсивний показник захворюваності на інші сальмонельозні інфекції становив 10,75 на 100 тис. населення (2023 рік 10,76 на 100 тис. населення) і був перевищений у Вінницькій (11,98 на 100 тис. населення), Чернівецькій (12,73 на 100 тис. населення), Київській (12,97 на 100 тис. населення), Одеській (13,63 на 100 тис. населення), Харківській (14,44 на 100 тис. населення), Полтавській (16,21 на 100 тис. населення), Дніпропетровській (16,29 на 100 тис. населення), місті Київ (16,52 на 100 тис. населення), Чернігівській (17,04 на 100 тис. населення), Черкаській (20,40 на 100 тис. населення), Сумській (19,93 на 100 тис. населення), Хмельницькій (21,29 на 100 тис. населення) областях.

В деяких регіонах, в яких середній по країні показник захворюваності був перевищений, все ж одночасно спостерігалось зниження захворюваності в порівнянні з 2023 роком. Так у Вінницькій області вона зменшилась на 15,49%, у Дніпропетровській на 5,08% у місті Київ на 7,68%, а в Одеській області аж на 26,67%. Загалом же зниження захворюваності на сальмонельози спостерігалось в 12 регіонах країни та місті Київ і варіювало від -4 випадки в Херсонській області до -65,17% в Тернопільській. Крім вищезазначених регіонів значне зменшення захворюваності на сальмонельоз було зареєстровано в Миколаївській (-22,45%) та Львівській (-23,98%) областях. **Діаграма 1.**

Діаграма 1. Динаміка захворюваності населення на сальмонельози по регіонах України за 2023-2024 роки(на 100 тис. населення)



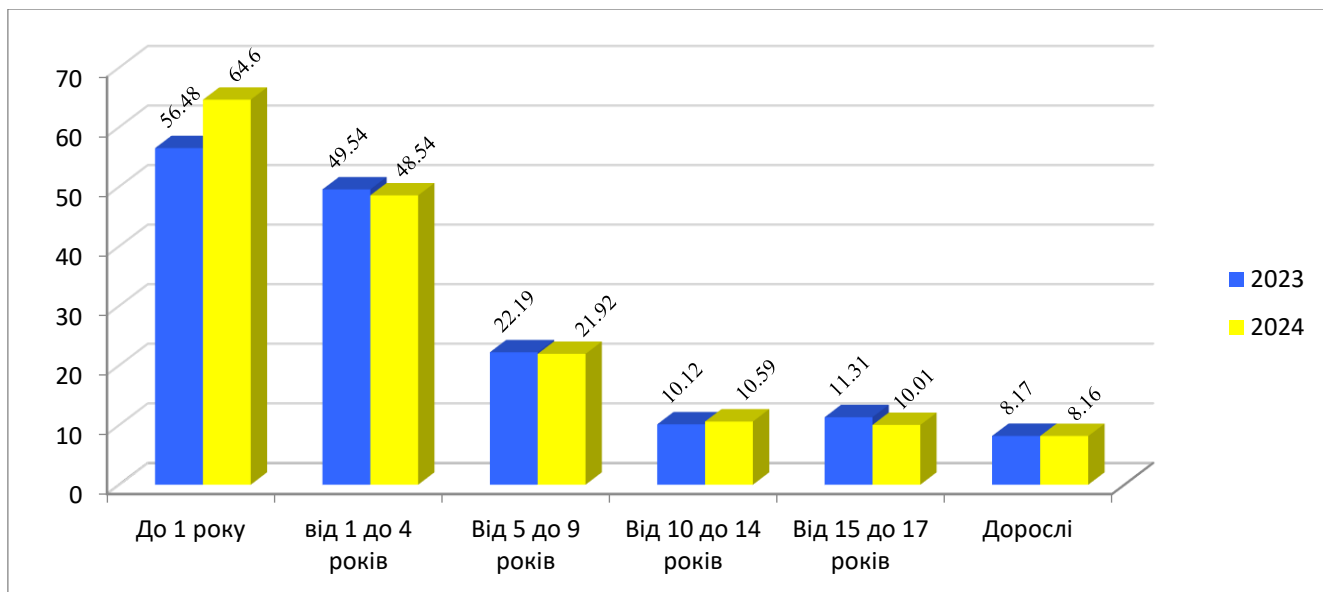
Особи, що проживали в містах хворіли частіше від осіб із сільських місцевостей. Так захворілих на сальмонельози містян було зареєстровано 3396 осіб, інтенсивний показник 11,93 на 100 тис. населення (2023 рік – 3446 осіб – 12,11 на 100 тис. населення). Жителів сільських населених пунктів захворіло в 3,36 рази менше – 1010 осіб з інтенсивним показником 8,05 на 100 тис. населення (2023 рік – 966 осіб – 7,70 на 100 тис. населення). Питома вага міського населення в загальній захворюваності сальмонельозами складала 77,1%, а сільського 22,9%. В цілому в 2024 році захворюваність серед міського населення зменшилась на 1,45%, тоді як серед сільських мешканців навпаки зросла на 4,55%. **Містяни** 12 регіонів та міста Київ хворіли менше на сальмонельози в порівнянні з минулим роком. Найбільшим спад захворюваності був в Львівській (-32,16%), Одеській (-37,64%), Тернопільській (-69,84%) областях. Однак захворюваність жителів міст 11 регіонів країни навпаки зросла, а найбільше в Київській (на 28,07%), Харківській (на 28,69%), Чернігівській (на 50,70%), Чернівецькій (на 62,79%) областях. Загальний приріст захворюваності **сільського населення** по країні був характерний і для 12 регіонів, а найбільшим він був в Одеській (22,78%), Чернівецькій (24%), Черкаській (27,45%), Київській (34,38%), Полтавській (50%) областях. Натомість статистичні дані 8 регіонів свідчили про зниження захворюваності на сальмонельози в сільській місцевості. Найбільшим цей показник був в Харківській (-22,37%), Вінницькій (-23,33%), Миколаївській (-29,00) областях.

Розподіл захворюваності серед вікових категорій дорослі/діти залишився майже на тому ж рівні, що і в 2023 році: дорослі – 8,16 на 100 тис. населення (2023 рік – 8,17 на 100 тис. населення), діти – 22,60 на 100 тис. населення (2023 рік – 22,63 на 100 тис. населення). Тобто розповсюдженість сальмонельозів серед дорослих, як і в минулому році, в 2,77 раз більша розповсюдженості серед дітей (2023 рік – 2,77).

Питома вага **дітей від 0 до 17 років** в загальній масі хворих на сальмонельози складала 37,7% (2023 рік – 37,7%). Середній по країні інтенсивний показник захворюваності серед дітей був перевищений в 7 регіонах та в місті Київ. Найбільшим це перевищення було: в місті Київ (36,23 на 100 тис. населення), Черкаській (42,44 на 100 тис. населення), Чернівецькій (42,45 на 100 тис. населення) та Харківській (54,84 на 100 тис. населення) областях. Серед дитячого населення спостерігалось хоч незначне, але зниження захворюваності на сальмонельози – 0,12%. Така тенденція була характерною і для 10 регіонів країни, а найбільш вираженою була в Львівській області (-18,38%), Тернопільській (-19,00%), Одеській (-31,64%) областях. Водночас процес зростання захворюваності в цій віковій категорії проявлявся у 8 областях та місті Київ і характеризувався збільшенням числа хворих дітей в Черкаській на 17,65%, Полтавській на 87,10%, Чернівецькій в 2,57 рази областях.

Інтенсивність захворюваності на сальмонельоз серед дітей відрізнялась по віковим групам. **Діаграма 2.**

Діаграма 2. Рівні захворюваності на сальмонельози в Україні в розрізі вікових груп за 2023-2024 роки (на 100 тис. населення)



Серед різних вікових груп рівень захворюваності варіював від зростання у категоріях: «Діти до 1-го року» - на 14,38%, «Діти від 10 до 14 років – на 4,66% до зниження на 2,02% в групі «Діти від 1 до 4 років», на 1,22% в групі «Діти від 5 до 9 років», на 11,51% - «Діти від 15 до 17 років».

Як і в попередні роки, найвищою залишається захворюваність серед дітей **до 1 року** – 64,60 на 100 тис. населення (2023 рік – 56,48 на 100 тис. населення). Поширеність сальмонельозів серед дітей цього віку мала діапазон від 13,15 на 100 тис. населення в Тернопільській області до 182,89 на 100 тис. населення в Харківській області. Інтенсивний показник був перевищений в 9 регіонах та місті Київ з вагомою перевагою у Волинській (81,6 на 100 тис. населення), Донецькій (89,53 на 100 тис. населення), Дніпропетровській (93,00 на 100 тис. населення), Хмельницькій (93,44 на 100 тис. населення), Миколаївській (100,34 на 100 тис. населення), Чернівецькій (113,9 на 100 тис. населення), Черкаській (118,71 на 100 тис. населення), Сумській (128,61 на 100 тис. населення) областях та вищезгаданій Харківській області (182,89 на 100 тис. населення). Частка захворілих дітей із цих регіонів сумарно складала 58,3% від всієї кількості хворих цієї вікової групи. Жодного випадку захворювання не було зареєстровано в Рівненській та Херсонській областях. В цілому захворюваність зросла на 14,38% серед дітей **до 1 року** – 175 випадків (2023 рік – 153 випадки). Така тенденція поширилась в 14 областях країни. Проте були регіони, в яких спостерігалось зниження захворюваності: Київська область (-1 вип.), Рівненська (-1 вип.), Черкаська (-1 вип.), місто Київ (-1 вип.), Львівська (4 вип.), Одеська (-6 вип.), Дніпропетровська області (-7 вип.).

Дещо зменшилась захворюваність серед дітей **від 1 до 4 років** – 629 вип. (2023 рік – 642 вип.). Ця закономірність охоплювала 12 регіонів країни та місто Київ, де спостерігалось зниження захворюваності сальмонельозами від 1

випадку в Івано-Франківській, Тернопільській областях до 47,06% в Одеській області, а в цілому по країні на 2,02%.

Проте ця вікова категорія залишилася, як і в попередні роки, найбільш вразливою. Рівень захворюваності якої складав 37,9% від загальної кількості дітей, що захворіли (2023 рік - 38,6%) та 14,3% від всіх хворих на сальмонельози (2023 рік - 14,6%). Поширеність сальмонельозів серед дітей зазначеної категорії була виражена середнім інтенсивним показником 48,54 на 100 тис. населення (2023 рік – 49,54 на 100 тис. населення). У 7 регіонах країни цей показник був перевищений: Миколаївська область (52,48 на 100 тис. населення), Запорізька (53,74 на 100 тис. населення), Полтавська (59,30 на 100 тис. населення), Черкаська (80,26 на 100 тис. населення), Дніпропетровська (82,64 на 100 тис. населення), Чернівецька (86,11 на 100 тис. населення), Харківська (141,29 на 100 тис. населення) та місто Київ (68,99 на 100 тис. населення). Сумарна кількість дітей, що перехворіли на сальмонельози з цих регіонів, складала 62,3% від всіх дітей зазначеної вікової категорії (2023 рік – 69,5%). Серед областей, в яких навпаки захворюваність зросла за минулий рік, найвищі показники збільшення випадків сальмонельозу були в Полтавській (на 7 вип.), Чернігівській (на 7 вип.), Миколаївській (на 9 вип.), Вінницькій (на 11 вип.), Чернівецькій (на 18 вип.) областях. Загалом по країні таких регіонів було 10.

Серед дітей **від 5 до 9 років** захворюваність протягом 2024 року зменшилась на 1,22%. Зниженням захворюваності було охоплено 10 областей країни і найбільшим воно було в Дніпропетровській (на 20,63%) і в Одеській (на 32,31%) областях. Всього захворіло 487 дітей від 5 до 9 років (2023 рік – 493 дітей). Питома вага цієї вікової групи становила 29,3% від всіх дітей, що перехворіли (2023 рік - 29,6%) і майже 11% від хворих всіх вікових категорій (2023 рік – 11,2%). Поширеність по країні серед цієї вікової категорії сальмонельозу була виражена середнім інтенсивним показником 21,92 на 100 тис. населення. В 9 регіонах і місті Київ було перевищення середнього інтенсивного показника. Загальна сума хворих дітей з цих областей нараховувала 76,8% від всіх хворих дітей зазначеної вікової групи. Діапазон переваги від 22,56 на 100 тис. в Донецькій області до 40,11 на 100 тис. в місті Київ та 50,79 на 100 тис. в Чернівецькій областях. Поряд із зменшенням захворюваності по країні в цілому, в 10 регіонах країни та місті Київ реєструвалось збільшення кількості випадків захворюваності на сальмонельози дитячого населення країни цього віку. Тут найбільшим ростом захворюваності характеризувались ті ж Чернівецька область (на 20 вип.) та місто Київ (на 20,69%).

Крім дітей до 1 року підвищення рівня захворюваності спостерігалось і в віковій категорії **від 10 до 14 років**, питома вага яких в загальній захворюваності становила 5,6% (2023 рік - 5,3%) і 14,9% (2023 рік - 14,2%) в дитячій. Захворюваність цієї категорії дітей зросла в середньому по країні з 10,12 на 100 тис. населення в 2023 році до 10,59 на 100 тис. населення в 2024 році. Перевищення середнього по країні інтенсивного показника було в 9 областях та місті Київ, а найбільше в Полтавській (16,97 на 100 тис. населення), Одеській (18,25 на 100 тис. населення), Сумській (17,69 на 100 тис. населення), Чернівецькій (18,53 на 100 тис. населення), Харківській (21,48 на 100 тис.

населення), Черкаській (24,92 на 100 тис. населення) областях та місті Київ (16,81 на 100 тис. населення). Сумарно хворі діти з цих регіонів склали майже 69% від загальної кількості хворих дітей цього віку. По країні захворюваність цієї вікової групи на сальмонельози збільшилась на 4,66% в цілому і по 11 регіонах та місті Київ зокрема з діапазоном від 1 випадку в Рівненській та Чернігівській областях до 11 випадків в Полтавській. Проте в 10 областях захворюваність порівняно з 2023 роком навпаки зменшилась з розмахом від -1 вип. в Дніпропетровській області до -8 в Тернопільській.

Поширеність сальмонельозу серед дітей **від 15 до 17 років** була виражена показником інтенсивності 10,01 на 100 тис. населення. Середнє значення по країні перевищено в 10 регіонах та місті Київ, та все ж в 4 областях це перевищення було найбільшим: в Дніпропетровській (17,25 на 100 тис. населення), Полтавській (19,02 на 100 тис. населення), Одеській (20,71 на 100 тис. населення), Черкаській (28,64 на 100 тис. населення) областях. Частка хворих з цих регіонів сумарно складала 38% від всіх дітей, що захворіли в цій віковій категорії. Загальна сума хворих на сальмонельози дітей 15-17 років в 2024 році становила 2,8% від хворих всіх вікових груп (2023 рік -3,2%) і 7,4% від дітей, що переохворіли (2023 рік - 8,4%). В більшості регіонів серед дітей цього віку захворюваність на сальмонельози знизилась з діапазоном від – 1 випадку в 6 областях до - 6 вип. в Донецькій, - 9 вип. в Тернопільській, а в цілому по Україні на -11,51%. У 8 регіонах країни та в місті Київ реєструвалось збільшення числа хворих на сальмонельози дітей цієї категорії. Збільшення випадків варіювало від 1 у Волинській та Івано-Франківській областях до 6 в Полтавській.

Майже на одному рівні залишилась захворюваність на сальмонельози **дорослого населення** країни – 2745 випадків (2023 рік – 2749 вип.). Поширеність сальмонельозів в цій категорії населення країни також практично не змінилась – 8,16 на 100 тис. населення (2023 рік – 8,17 на 100 тис. населення). В 9 областях країни та в місті Київ цей показник було перевищено, однак в 5 регіонах найбільше: в Полтавській (14,30 на 100 тис. населення), Черкаській (16,11 на 100 тис. населення), Чернігівській (17,13 на 100 тис. населення), Сумській (19,56 на 100 тис. населення), Хмельницькій (20,04 на 100 тис. населення) областях. Разом в цих регіонах захворіло 824 особи – 30% від людей, що переохворіли цієї категорії населення. Питома вага дорослих хворих в загальній захворюваності на сальмонельози складала 62,3% (2023 рік - 62,3%). Напрямо до зниження захворюваності в цілому по країні (на – 0,15%) поширився і на 12 регіонів та місто Київ. Але найбільшим він був в Одеській (-23,26%), Львівській (-27,61%), Вінницькій (-27,78%), Миколаївській (-32,08%), Тернопільській (-68,42%) областях. Втім не на всій території країни зменшувалось число хворих на сальмонельози серед дорослих. Так ріст захворюваності простежувався в 11 регіонах з інтервалом значень від 4 випадків в Чернівецькій області до збільшення випадків сальмонельозів на 46,79% в Полтавській, на 56,04% в Харківській, на 59,30% в Чернігівській, на 67,74% в Київській областях.

В 2024 році в Україні було зареєстровано 20 спалахів сальмонельозів (2023 рік – 25; 2022 рік – 16). З них: по 1 спалаху в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській,

Хмельницькій, Чернігівській областях, по 2 спалахи в Одеській, Черкаській і Чернівецькій. Та найбільшою була, як і в минулому році, кількість спалахів в місті Києві – 4 (2023 рік – 11).

І хоча кількість спалахів стала порівняно меншою, чисельність постраждалих залишилась майже однаковою – 235 осіб (2023 рік – 237). При цьому 16% (38 осіб) від всіх постраждалих - це діти (2023 рік - 60 дітей – 25,3%). Кількість хворих при спалахах сальмонельозу складала 5,3% від всіх офіційно зареєстрованих випадків захворювань на сальмонельози (2023 рік - 5,4%).

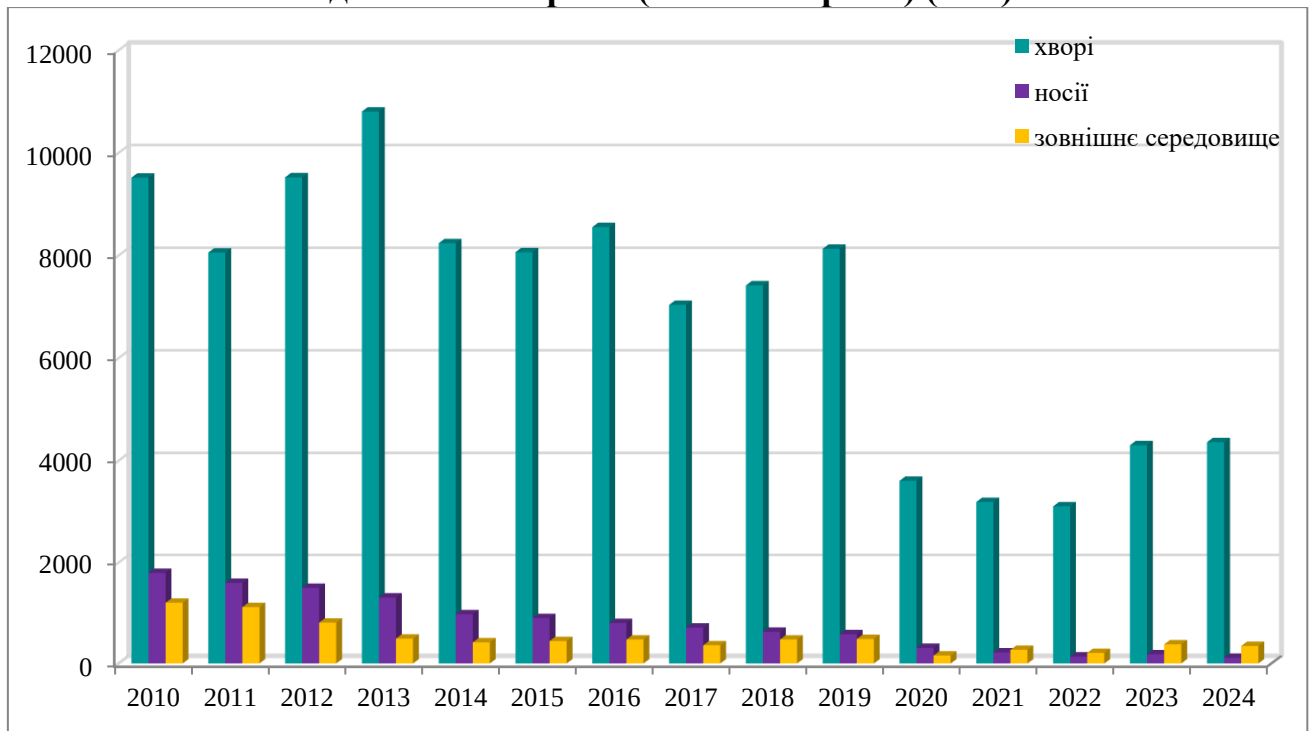
В 75% випадків спалахів чинниками захворювань були *S. Enteritidis*, яка була виділена із 15 спалахів; в 20% випадків (4 спалахи) – *S. Typhimurium* і причиною одного спалаху (5%) стала *S. Bovismorbificans*.

Основні причини та обставини виникнення спалахів не зазнали значних змін:

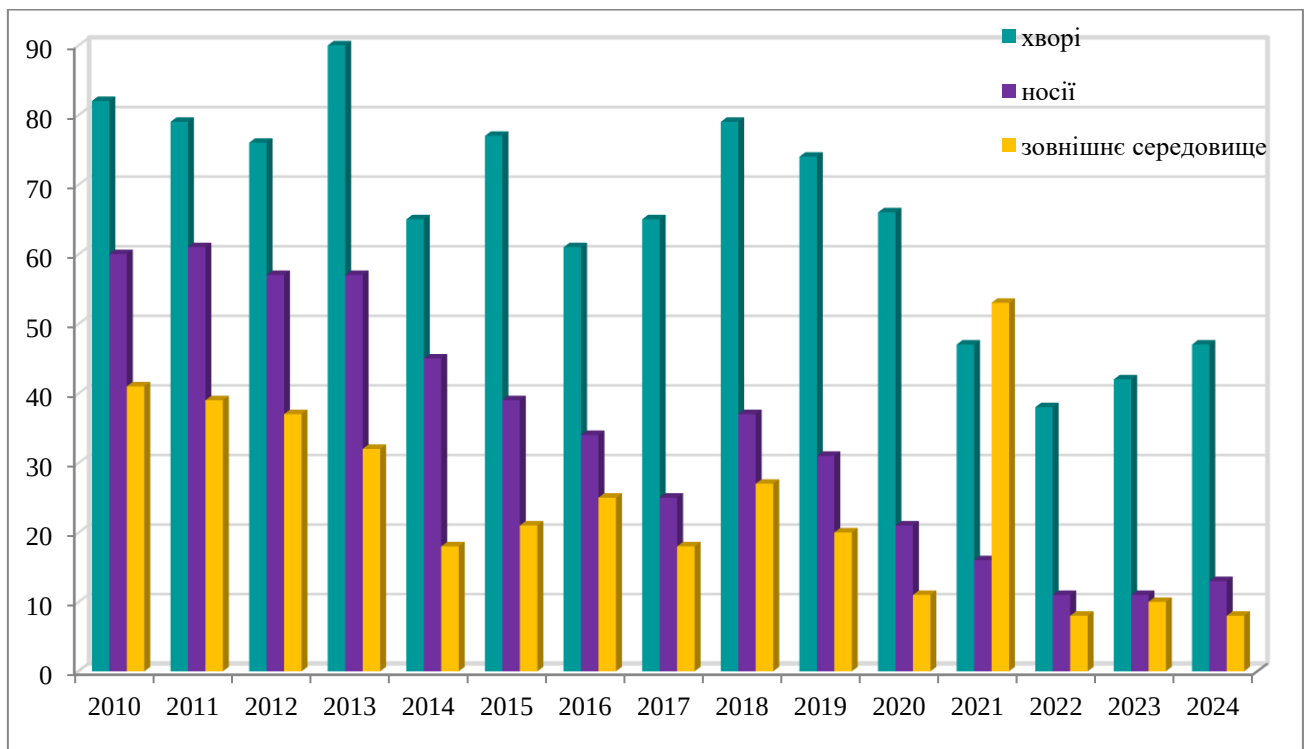
порушення санітарно-гігієнічних вимог та технології приготування їжі, недотримання поточності готової і сирової продукції, товарного сусідства харчових продуктів в холодильному обладнанні, порушення процесу розморожування сировини, правил особистої гігієни працівниками харчоблоку, порушення дезінфекційного режиму, правил миття обладнання та інвентарю, недотримання правил маркування та експлуатації за призначенням кухонного інвентарю, не дотримання поточності технологічного процесу виробництва готових до споживання страв, відсутність розмежування технологічних процесів обробки сирих та готових харчових продуктів, недостатній технологічний контроль за процесом виготовлення страв, недостатня забезпеченість холодильним обладнанням, роздрібним інвентарем, столовим посудом, столовими приборами, відсутність умов для окремого зберігання перероблених харчових продуктів (готові харчові продукти) та не перероблених харчових продуктів, відсутність контролю температурного режиму в холодильному обладнанні, недотримання вимог поводження з харчовими відходами, тощо. Новими обставинами, що мали безпосередній зв'язок із війною в країні, стали порушення умов зберігання готових продуктів харчування, у зв'язку з відключенням електроенергії.

Бактеріологічними лабораторіями закладів охорони здоров'я країни при проведенні досліджень з метою діагностики ГКІ в 2024 році було виділено 4359 штамів сальмонел, що на 1,35% більше попереднього року (2023 рік – 4301), визначено 47 сероварів (2023 рік – 42). В 1 випадку сальмонела не визначена по серогрупі серед рідкісних серогруп і ще 22 сальмонели не типовані в серогрупах. При обстеженні здорового населення виявлено носіїв 112 штамів сальмонел (2023 рік - 182), 13 сероварів (2023 рік – 11). Не визначені серогрупи сальмонел в 3 випадках. З об'єктів середовища життєдіяльності людини (далі - СЖЛ) – 348 штамів сальмонел (2023 рік – 380), 8 сероварів (2023 рік – 10). Серовар ще однієї сальмонели не визначено (діаграми 3, 4).

Діаграма 3. Кількість штамів сальмонел виділених в Україні (2010-2024 роки) (абс.)



Діаграма 4. Кількість сероварів сальмонел виділених в Україні (2010-2024 роки) (абс.)



В Україні в 2023 році, в порівнянні з минулим роком, дещо змінився перелік сероварів сальмонел, які найбільш часто зустрічалися серед людей та із зовнішнього середовища. **Таблиця 1.**

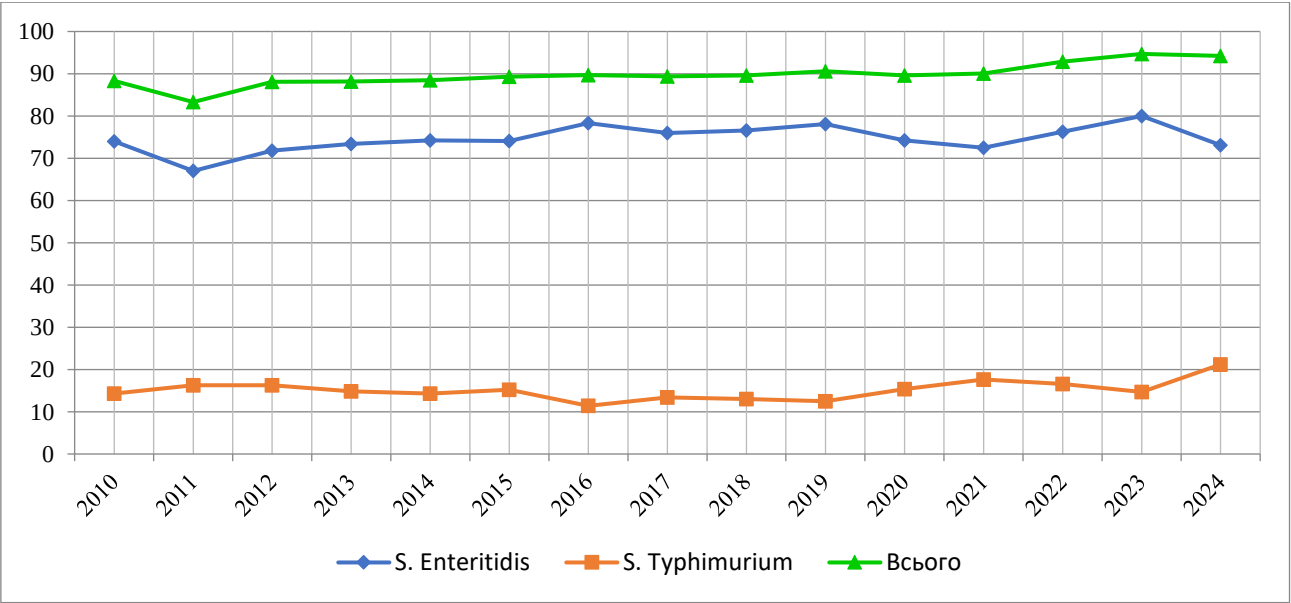
Таблиця 1. Серовари сальмонел, які найбільш часто виділялися з матеріалу від людей та СЖЛ (%) в Україні (2023-2024 роки)

	Хворі				Носії				СЖЛ			
	2023 рік		2024 рік		2023 рік		2024 рік		2023 рік		2024 рік	
1	Enteritidis	80,0	Enteritidis	73,1	Enteritidis	65,4	Enteritidis	63,4	Enteritidis	66,3	Enteritidis	67,8
2	Typhimurium	14,7	Typhimurium	21,2	Typhimurium	26,4	Typhimurium	22,3	Typhimurium	58,8	Typhimurium	27,8
3	Blegdam	1,2	Infantis	0,9	London	2,2	Infantis Rissen	1,8	Derby	41,2	Bovismorbifikans	2,0

У спектрі виділених **від хворих** сальмонел, як і в попередні роки, домінуючими на території України залишаються серологічні варіанти *S.Enteritidis* та *S.Typhimurium*, їх загальна питома вага була високою і складала 94,2% (2023 рік – 94,7%). Питома вага захворювань сальмонельозом, викликаних сумарно цими збудниками по регіонах України варіювала 83,1% в Запорізькій області до 100% в Житомирській, Івано-Франківській, Тернопільській, Херсонській областях.

В порівнянні з минулим роком дещо зросла етіологічна роль у захворюваності сальмонельозами *S.Typhimurium*. Так в 2024 році *S.Enteritidis* стала причиною виникнення сальмонельозів у 73,1% випадків (2023 рік - 80%), а *S.Typhimurium* у 21,2% випадків (2023 рік – 14,7%). **Діаграма 5.**

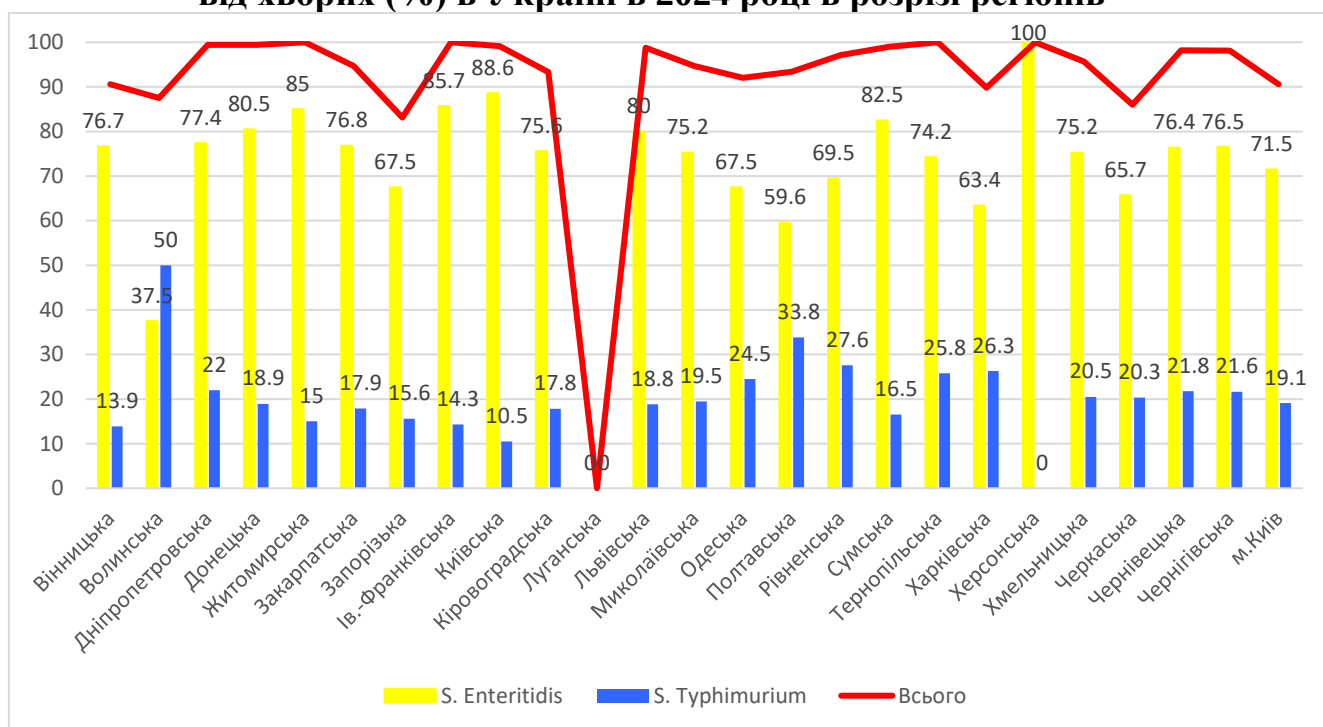
Діаграма 5. Питома вага *S.Enteritidis* та *S.Typhimurium*, виділених від хворих (%) в Україні (2010-2024 роки)



По областях відсоток сальмонельозів, викликаних *S.Enteritidis*, варіював від 37,5% у Волинській області до 88,6% в Київській, а *S.Typhimurium* від 10,5%

в Київській області до 50,0% в Волинській. В Херсонській області від хворих виділена 1 сальмонела, яка належала до серовару *S.Enteritidis*. Діаграма 6.

Діаграма 6. Питома вага *S.Enteritidis* та *S.Typhimurium*, виділених від хворих (%) в Україні в 2024 році в розрізі регіонів



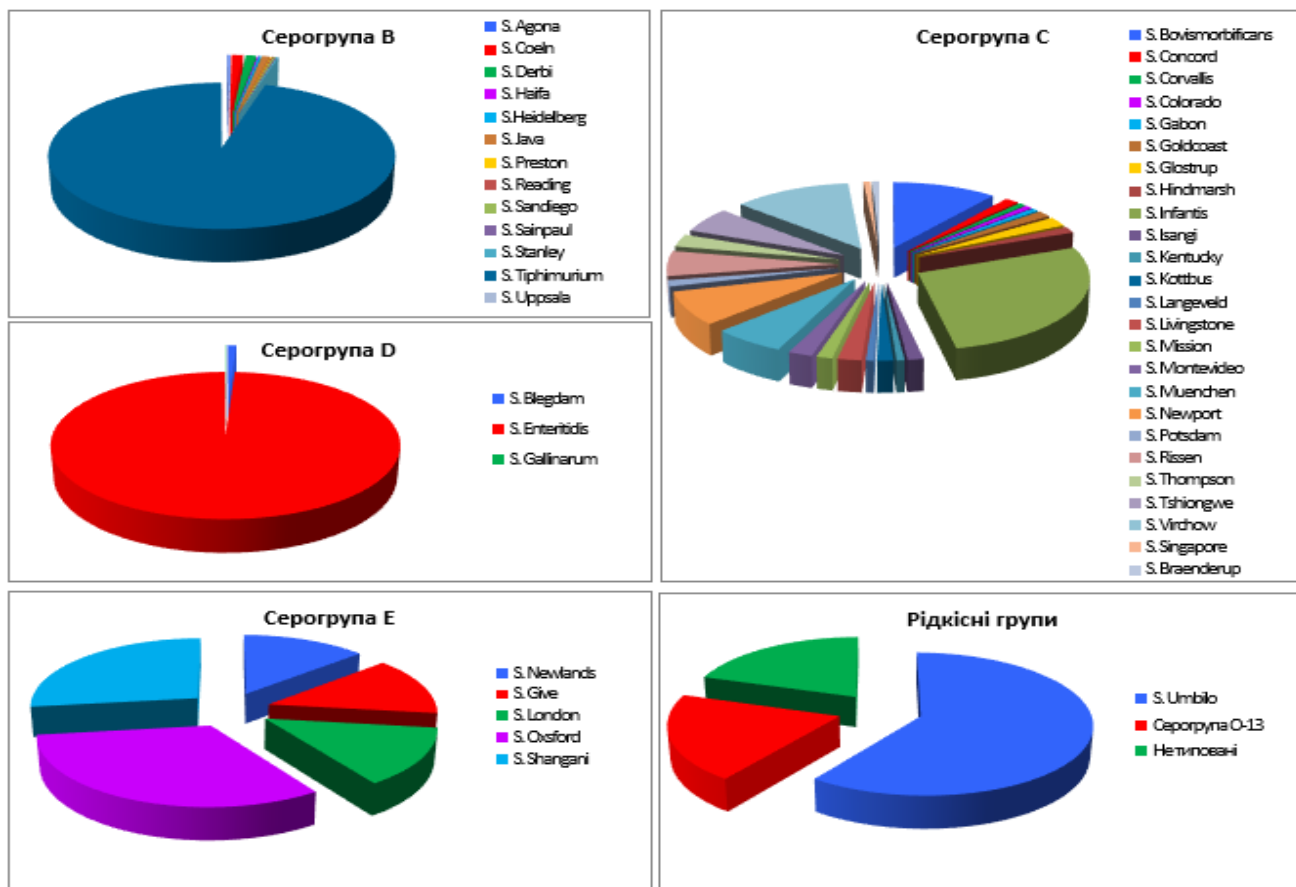
В трійку найпоширеніших збудників сальмонельозу увійшла в цьому році *S. Infantis*, на відміну від минулого року, коли третє місце посідала *S. Blegdam*. В цілому по країні частка *S. Infantis* в загальній сумі виділених сальмонел складала 0,89% (2023 рік – 0,53%). Загалом *S. Infantis* була виділена в 8 областях країни. Найбільше цього збудника було виділено в Харківській області – 25 штамів, що складало майже 7% від всіх виділених сальмонел в цьому регіоні країни (2023 рік – 15 штамів - 5% від загального числа по області). *S. Infantis* також була серед знахідок в Черкаській області - 4 штами, та по 3 штами в Запорізькій області та в місті Київ.

Також не втрачає своєї значимості і *S.Blegdam*. В 2024 році її кількість серед всіх ізолятів сальмонел, виділених від хворих, склала 0,71% (2023 рік – 1.21%) і зустрічалася лише в трьох регіонах: у Вінницькій (15 штамів), Запорізькій (13 штамів) та Одеській (3 штами) областях. *S. Virchow* теж була причиною значної частини захворювань на сальмонельози. Її частка в загальній сумі виділених збудників становила 0,39% (2023 рік – 0,4%). Поширений цей збудник був в 6 областях, а найбільше виділень було у Волинській та Одеській областях (6 штамів).

З'явилися в 2024 році і нові сальмонели, які зайняли провідні позиції серед збудників сальмонельозів. Одним з таких сероварів стала *S. Bovismorbificans* (0,34% від всіх сальмонел). Хоча розповсюдженість її по країні була низькою і виділялась лише в Черкаській області – 14 штамів та в місті Київ – 1 штам.

Загалом в підзвітному році спостерігалось збільшення різноманіття ідентифікованих сальмонел. Так якщо в серогрупі D їх було виділено 3 серовара, в серогрупі E – 5, то в серогрупі B -13, а в серогрупі C – аж 25 серологічних варіантів. **Діаграма 7.**

Діаграма 7. Пейзаж сероварів сальмонел, виділених від хворих в 2024 році



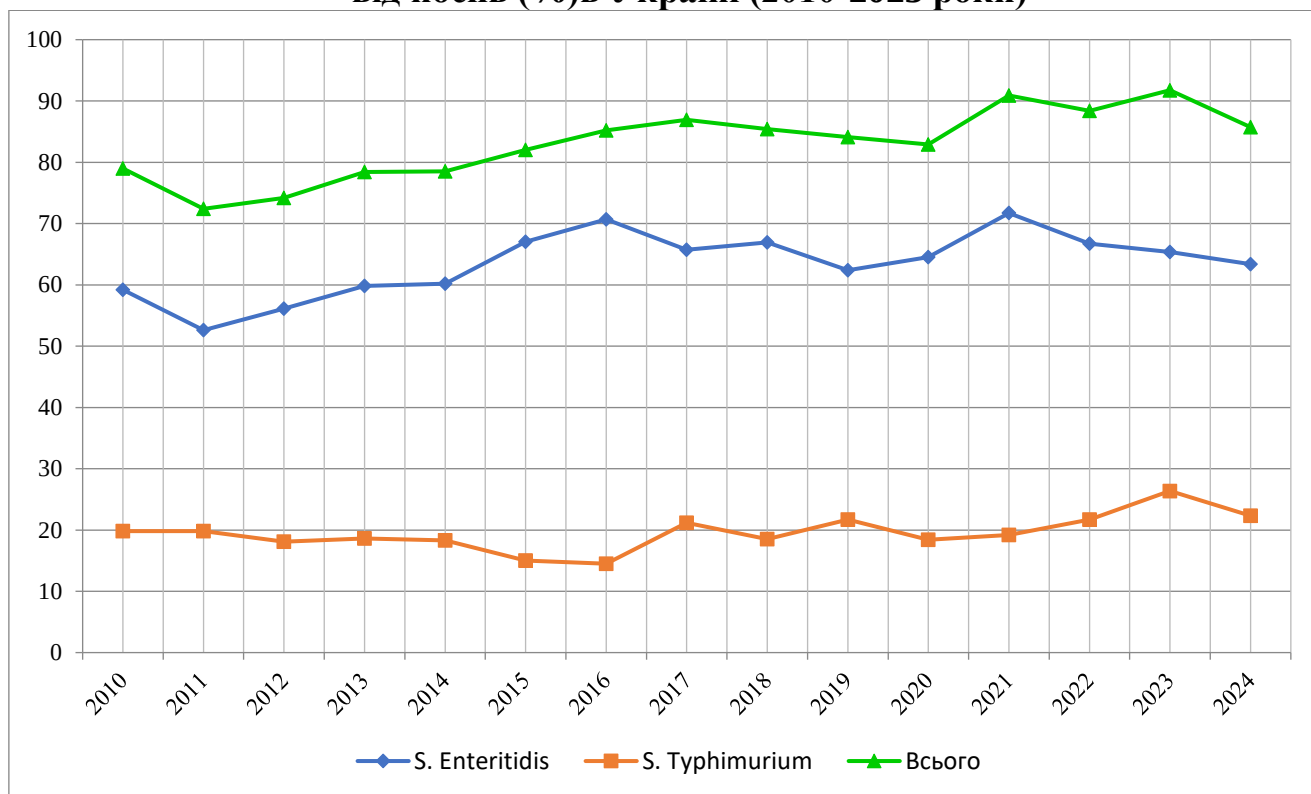
У значної частини сальмонел серовар не було визначено. Так по країні не типована 1 сальмонела рідкісних груп, в однієї сальмонели не визначено серовар в групі O-13 і аж 22 сальмонели не типовані в серогрупах. **Звертаємо увагу, що штами у яких ускладнене серологічне типування, необхідно надсилати до ДУ «ЦГЗ МОЗ України».**

При обстеженні здорового населення виділено 112 штамів сальмонел. Це на 38,5% менше ніж в 2023 році (182 штамів). Носії збудників сальмонельозу були виявлені при бактеріологічному дослідженні в 15 регіонах країни (2023 рік – 16 регіонів і м. Київ). Найбільша кількість носіїв цих збудників спостерігалась в Дніпропетровській (26 штамів – 23% від усіх сальмонел від носіїв), Харківській (15 штамів – 13,4% від усіх сальмонел від носіїв) областях та місті Київ (14 штамів – 12,5%). Питома вага знахідок сальмонельозного носійства в цих регіонах від загального по країні складала 49,1%. Жодного випадку виявлення сальмонел при дослідженні на носійство не було виявлено у Вінницькій,

Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій областях.

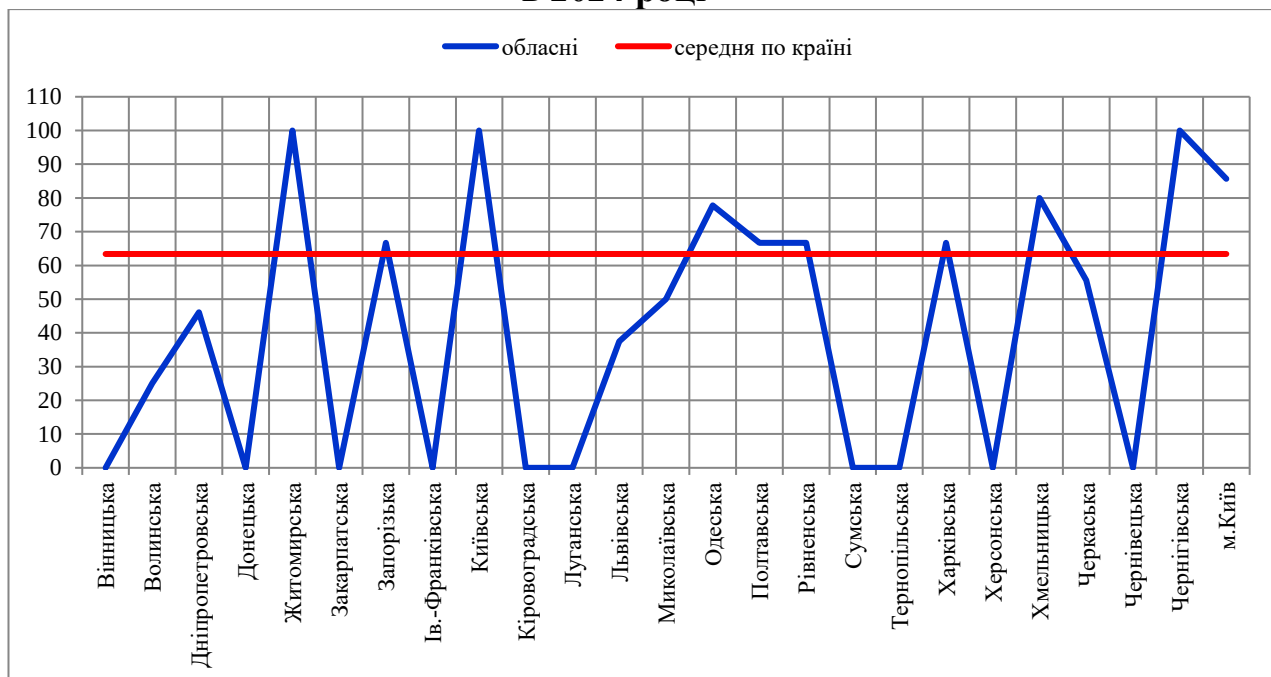
Кількість сероварів сальмонел виділених від носіїв залишилась майже на одному рівні - 13 (2023 рік – 11). Як і в минулому році домінуючими залишаються *S.Enteritidis* та *S.Typhimurium*, які в сумі склали 85,71% (2023 рік - 91,75%) від всіх виділених збудників сальмонельозів при обстеженні здорових людей. Як і раніше переважала *S.Enteritidis* - 63,39% (2023 рік - 65,38%), а питома вага *S.Typhimurium* становила 22,32% (2023 рік - 26,37%). **Діаграма 8.**

Діаграма 8. Питома вага *S.Enteritidis* та *S.Typhimurium*, виділених від носіїв (%) в Україні (2010-2023 роки)



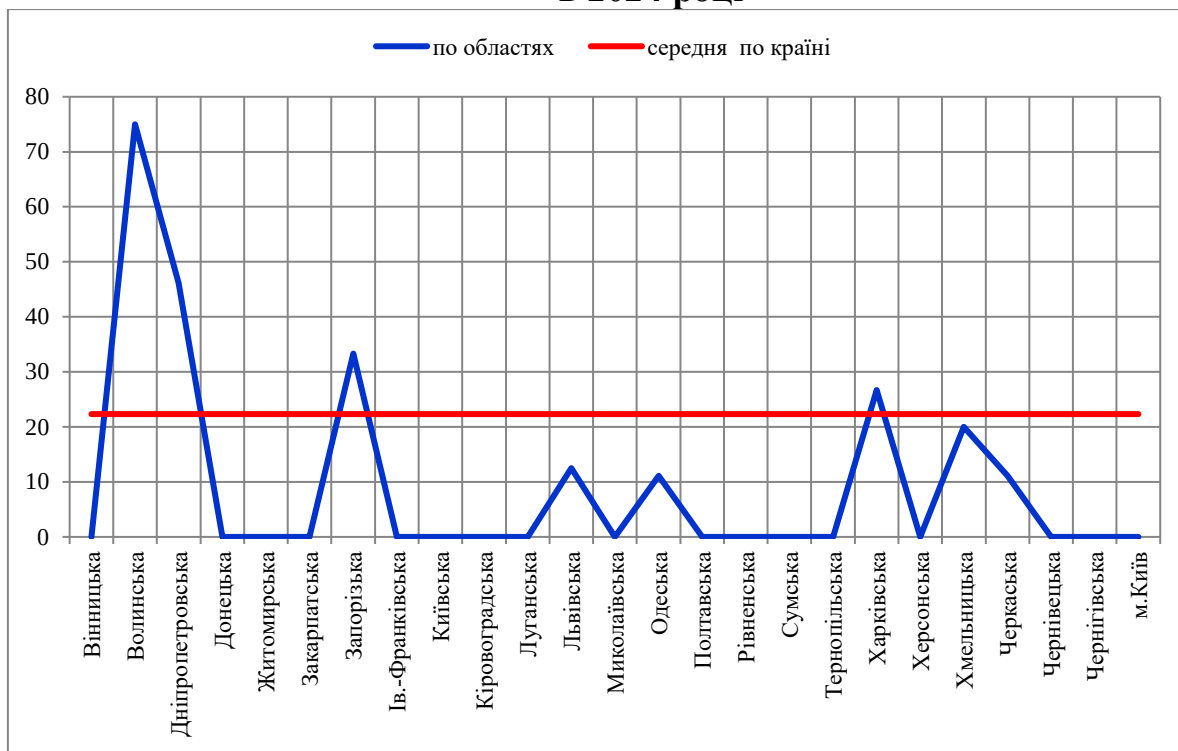
У 14 регіонах країни та місті Київ було виділено *S.Enteritidis* при обстеженні осіб без клінічних проявів сальмонельозу (2023 рік – 15). Питома вага носіїв цього збудника коливалась від 25% у Волинській області до 100% у Житомирській, Київській, Чернігівській областях. Жодної носія *S.Enteritidis* не було знайдено у Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Сумській, Тернопільській, Чернівецькій областях. **Діаграма 9.**

Діаграма 9. Питома вага носіїв *S.Enteritidis* (%) в розрізі регіонів в 2024 році



Дещо знизилась питома вага *S.Typhimurium* в порівнянні з 2023 роком. В спектрі виділених від носіїв сальмонел цей збудник становив 22,23% (2023 рік – 26,37%). Загалом *S.Typhimurium* була виділена в цій категорії населення у 8 регіонах країни (2023 рік – 9). А саме: в Одеській і Черкаській областях (по 11,11% від всіх знайдених сальмонел в цій категорії осіб), Львівській (12,5%), Хмельницькій (20%), Харківській (26,67%), Запорізькій (33,33%), Дніпропетровській (46,15%), Волинській (75%) областях. В 14 регіонах та м. Київ цей збудник не виділявся взагалі: у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в місті Київ. **Діаграма 10.**

Діаграма 10. Питома вага носіїв *S.Typhimurium* (%) в розрізі регіонів в 2024 році



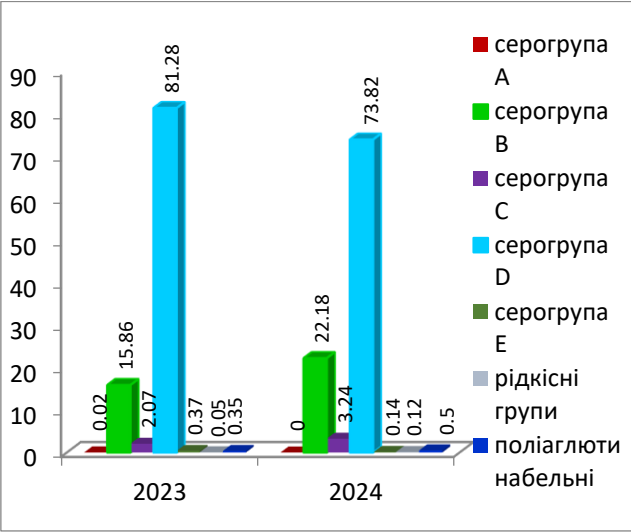
В спектрі виділених від носіїв сальмонел *S.Typhimurium* та *S.Enteritidis* були єдиними представниками своїх серогруп В і D. Та більш різноманітна палітра штамів сальмонел в серогрупі С. Серед них ідентифіковані як ті серовари, що часто зустрічаються, такі як: *S. Infantis* (1,79% від всіх сальмонел в цій категорії осіб),

S. Kentucky (0,89%), *S. Livingstone* (0,89%), *S. Montevideo* (0,89%), *S. Muenchen* (0,89%), *S. Rissen* (1,79%), *S. Thompson* (0,89%), *S. Virchow* (0,89%), так і менш розповсюджені: *S. Ardwick* (0,89%) та *S. Bovismorbifikans* (0,89%). Ще у 3 сальмонел залишились не визначені ні серогрупи ні серовари.

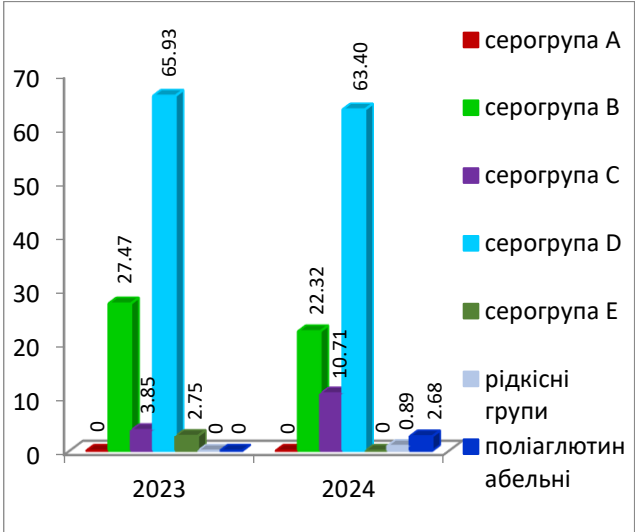
Переважає більшість сальмонел, виділених як від хворих – 73,82% (2023 рік - 81,28%) так і носіїв – 63,40% (2023 рік - 65,93%), як і в минулі роки, належать до серогрупи D. Всього було виділено з цієї серогрупи сальмонел 3 серологічних варіанта від хворих (2023 рік - 4) і 1 серологічний варіант від носіїв (2023 рік -1). Другою серологічною групою, що превалює в обох категоріях обстежуваних, є серогрупа В. Від хворих сальмонели цієї серогрупи були виділені у 22,18% випадків (2023 рік - 15,86%), а від носіїв у 22,32% (2023 рік - 27,47%). Загалом сальмонел цієї серогрупи ідентифіковано від хворих – 13 сероварів (2023 рік – 14), від носіїв - 1 серовар (2023 рік – 3). Найбільш різноманітна палітра серологічних варіантів сальмонел була в серологічній групі С: від хворих – 25 серологічних варіантів (2023 рік – 18), від носіїв – 10 (2023 рік - 5). Зросла і вагомість цієї серогрупи. Серед виділених збудників від хворих сальмонели серогрупи С становили 3,24% (2023 рік – 2,07%) і 10,71% від носіїв (2023 рік – 3,85%).

Діаграми 11, 12.

Діаграма 11. Розподіл по серогрупах сальмонел (%), виділених від хворих (2023-2024 роки)

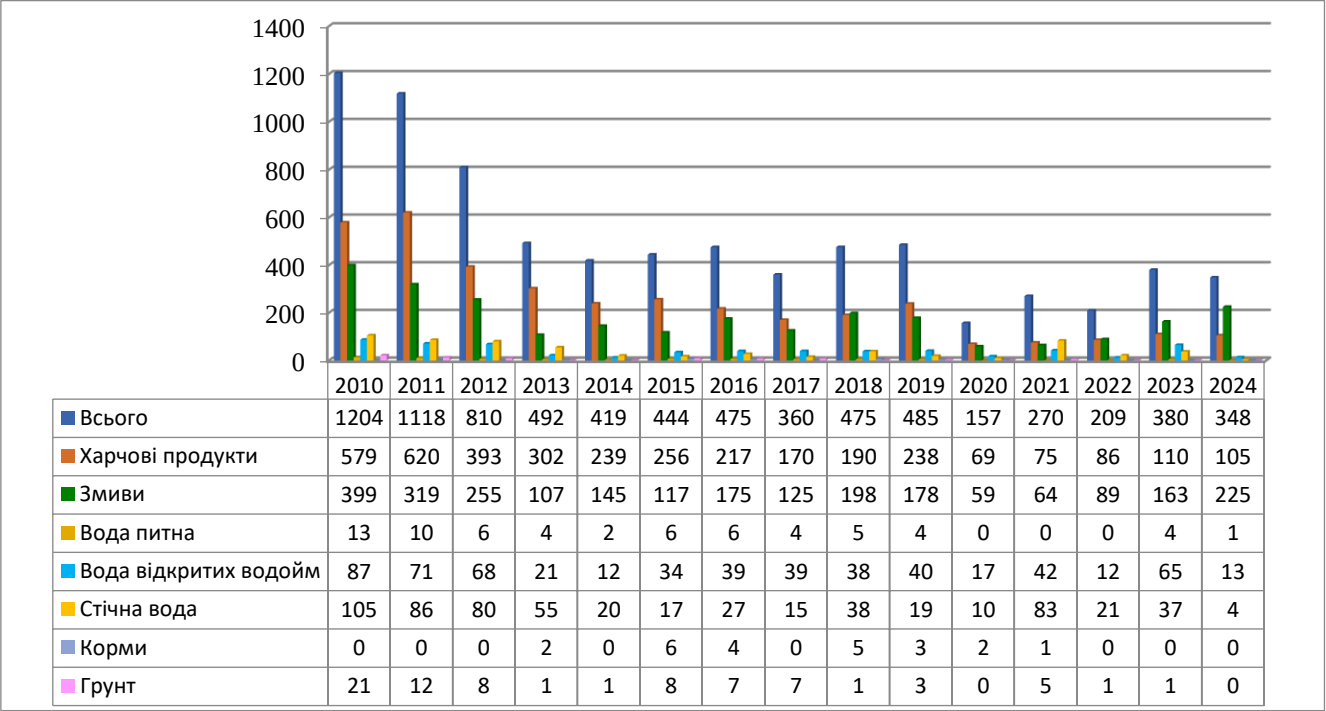


Діаграма 12. Розподіл по серогрупах сальмонел (%), виділених від носіїв (2023-2024 роки)



Визначення факторів передачі в інфекційному контролі за хворобами харчового походження, в тому числі сальмонельозу, є невід’ємною частиною системи епідагляду. Тому бактеріологічне дослідження об’єктів середовища життєдіяльності людини є важливим інструментом у виявленні збудника та контролю над його поширенням. Діаграма 13.

Діаграма 13. Кількість штамів сальмонел виділених з об’єктів середовища життєдіяльності людини (2010-2024 роки)(абс.)



Кількість штамів сальмонел виділених із об’єктів середовища життєдіяльності людини в 2024 році зменшилась на 8,4% в порівнянні з минулим

роком. Було виділено 348 штамів сальмонел 8 серологічних варіантів (2023 рік – 380 штамів 10 сероварів). Загалом по країні із СЖЛ сальмонели були ізолювані в 11 регіонах та місті Київ (2023 рік – в 15 регіонах та місті Київ). Як і в минулому році найбільше штамів сальмонел було виділено в Дніпропетровській області – 275 (2023 рік – 227), що становить 79% від загальної суми виділених штамів по країні. В Хмельницькій області кількість позитивних знахідок складала 36 штамів (10% від всіх виділених сальмонел), в Черкаській області – 20 штамів (5,7% від всіх виділених сальмонел).

Жодного випадку виявлення сальмонел з СЖЛ не було в 12 областях.

Кількість штамів сальмонел виділених з харчових продуктів зменшилась на 8,4%, з питної води на 75%, з води відкритих водойм на 80%, із стічної води на 89%. З ґрунту сальмонели не виділялись зовсім.

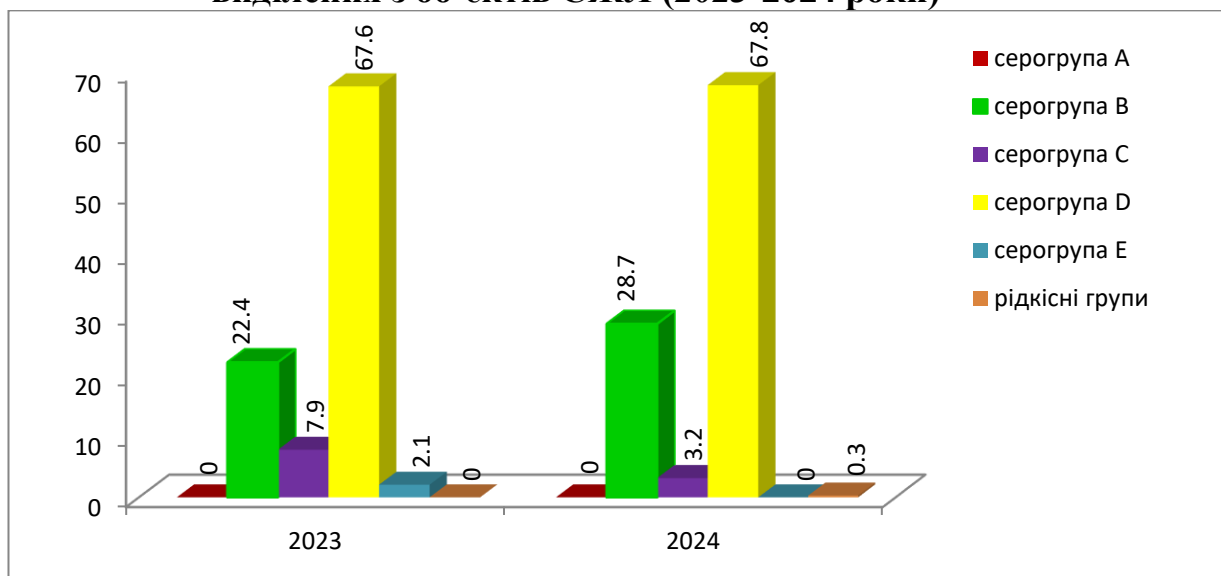
І навпаки на 38% збільшилось число виділень збудників сальмонельозу із змивів.

В порівнянні з минулим роком зменшився перелік серологічних варіантів сальмонел, ізолюваних із СЖЛ. По 3 серологічні варіанти було ідентифіковано з м'яса (2023 рік – 3), птиці (2023 рік – 5), яєць (2023 рік – 2), риби (2023 рік – 2), кулінарних виробів (2023 рік – 4), змивів (2023 рік – 5), води відкритих водойм (2023 рік – 5), стічної води (2023 рік – 6), по 2 серовара з молочних продуктів (2023 рік – 1) та інших харчових продуктів (2023 рік -2), та 1 серовар з кондитерських виробів (2023 рік – 2).

Серологічні варіанти сальмонел, які найбільш часто виділялися з проб об'єктів СЖЛ, наведені в **таблиці 1**.

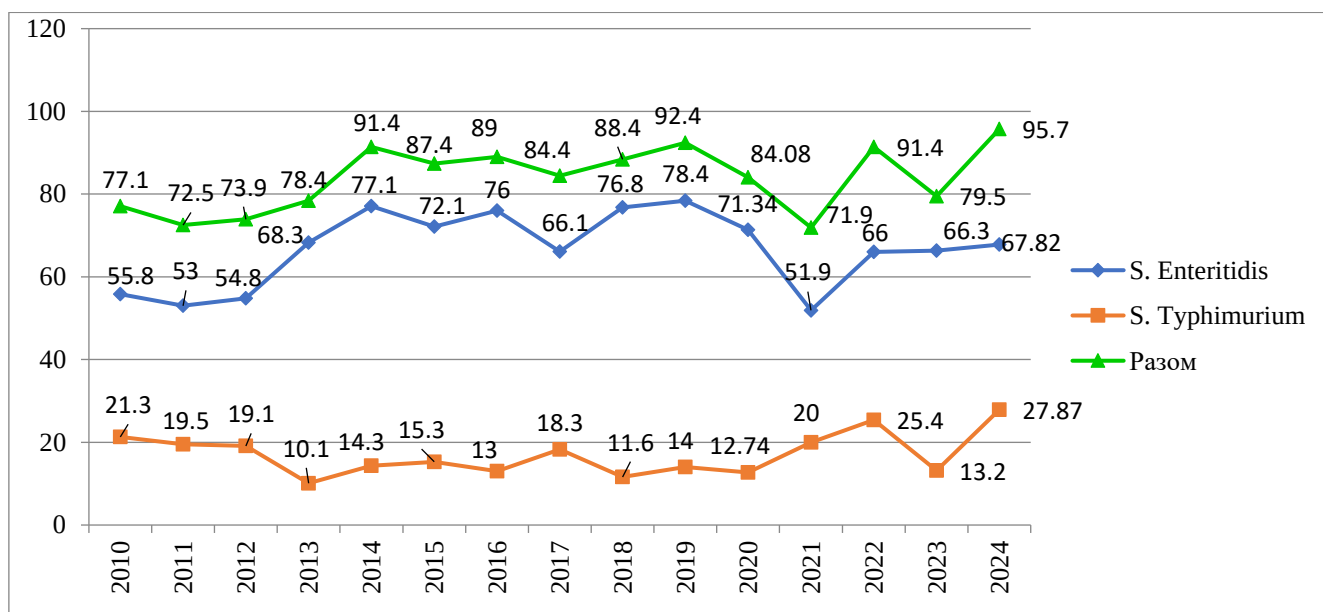
Найширшим спектр сальмонел, виділених із СЖЛ, був в серогрупі С – 4 серовара (2023 рік - 5 сероварів). 3 серологічних варіантів сальмонел належали до групи В і лише один серовар належав до групи D, але по кількості він переважав інші серовари виділених штамів і складав 67,8% від всіх сальмонел (236 культур), виділених з СЖЛ. При дослідженнях з об'єктів СЖЛ за 2024 рік одна сальмонела не була типована. **Діаграма 14.**

Діаграма 14. Співвідношення серологічних груп сальмонел (%), виділених з об'єктів СЖЛ (2023-2024 роки)



Багаторічна перевага пари *S.Enteritidis* та *S.Typhimurium* над іншими серологічними варіантами сальмонел зберіглася і в 2024 році. Питома вага цих збудників склала 95,7% від всіх виділених штамів (2023 рік – 79,5%) і збільшилась в порівнянні з попереднім роком на 10,3%. Так само збільшилась в підзвітному році частка *S.Typhimurium* – 97 штамів - 27,87% від загальної кількості штамів із СЖЛ (2023 рік – 50 штамів – 13,6%). Натомість *S.Enteritidis* в 2024 році виділялась менше – 236 штамів – 67,82% (2023 рік – 252 штами – 66,32%). Таким чином перевага *S.Enteritidis* над *S.Typhimurium* в 5 разів в 2023 році зменшилась і становила у 2024 році 2,4%. **Діаграма 15.**

Діаграма 15. Питома вага *S.Enteritidis* та *S.Typhimurium*, виділених з об'єктів СЖЛ в Україні в 2010-2024 роках (%)



Поширеність сальмонел можна легко простежити, оцінивши, які серовари впливають на людей, а також ізольовані із заражених харчових продуктів. Найбільш споживаними продуктами тваринного походження, пов'язаними з захворюваннями харчового походження, які впливають на здоров'я населення в усьому світі, є кури, свинина, яловичина, яйця, молоко та морепродукти. Крім того, бактерії із заражених продуктів тваринного походження забруднюють обладнання на підприємствах з переробки харчових продуктів, зрештою створюючи небезпечні продукти, які можуть вплинути на здоров'я людини. В 2024 році найбільш інфікованими сальмонелами продуктами виявилися:

- Яйця та продукти з яєць – 54 штами – 15,5% від виявлених сальмонел в СЖЛ (2023 рік - 61 штами - 16,1%)
- М'ясо птиці – 17 штамів – 4,9% (2023 рік - 9 штамів – 2,4%)
- М'ясо та м'ясопродукти – 12 штамів - 3,4% (2023 рік - 7 штамів – 1,8%)
- Кулінарні вироби – 10 штамів – 2,9% (2023 рік - 8 штамів – 2,1%)
- Риба та рибопродукти – 7 штамів – 2% (2023 рік - 5 штамів – 1,3%)
- Молоко і молочні продукти – 2 штами – 0,6% (2023 рік - 2 штами - 0,5%)

Домінування окремих сероварів сальмонел, таких як *S. Enteritidis* та *S. Typhimurium* свідчить про їх першочергову роль в інфікуванні харчових продуктів, насамперед тваринного походження. В 2024 році ці збудники сумарно склали 91,4% (2023 рік – 87%) в загальній сумі штамів сальмонел, виділених з харчових продуктів. Видовий склад сальмонел зменшився і змінився. Не було серед знахідок 2024 року *S. Virchow*, *S. Kottbus*, *S. Livingstone*, *S. Infantis*, *S. Blegdam*, *S. London*, які були серед ідентифікованих сальмонел 2023 року. Натомість з'явилися нові серологічні варіанти сальмонел серогрупи C: *S. Bovismorbifikans* в м'ясі, яйцях, рибі, в кулінарних виробках, *S. Glostrup* в інших харчових продуктах, *S. Menston* в м'ясі птиці.

Як і в минулому році, найбільше сальмонел з харчових продуктів було ізольовано в Дніпропетровській області – 53 штами (2023 рік – 50). 23 штами було виділено в Хмельницькій області (2023 рік – 14), 15 штамів в Черкаській області (2023 рік – 9). Сумарно в цих трьох регіонах було виділено 91 штам сальмонел, питома частка яких складала 86,7% від усієї кількості знахідок по країні.

В 12 областях сальмонели з продуктів харчування не виділялись.

При дослідженні змивів виділено 225 штамів сальмонел – 64,7% від всіх штамів з СЖЛ (2023 рік - 163 штамів – 43%). Сальмонели в змивах були ідентифіковані в 4 регіонах і місті Київ: Дніпропетровській області – 209 штамів, Хмельницька область – 13 штамів, по 1 штаму в Черкаській області та місті Київ.

Позитивні знахідки по сальмонелам були також у воді відкритих водойм – 13 штамів – 3,7% від всіх з СЖЛ (2023 рік - 65 штамів – 17%), які виділені лише в Дніпропетровській – 9 штамів (2023 рік – 20 штамів) та в Черкаській областях – 4 штами (2023 рік – 0).

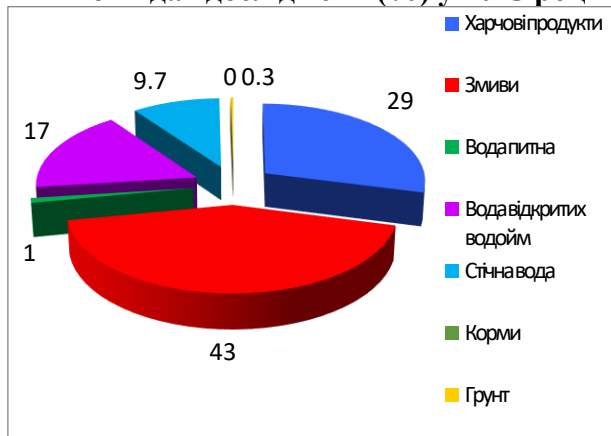
Зменшилась на 89,2% кількість сальмонел, виділених з стічної води – 4 штами -1,1% (2023 рік – 37 штамів - 9,7%). Регіон, в якому був ідентифікований цей збудник, був лише один: Дніпропетровська область.

Лише у Львівській області виділена 1 сальмонела в питній воді – 0,3% від усіх сальмонел, що виділені з СЖЛ (2023 рік - 4 штами – 1%).

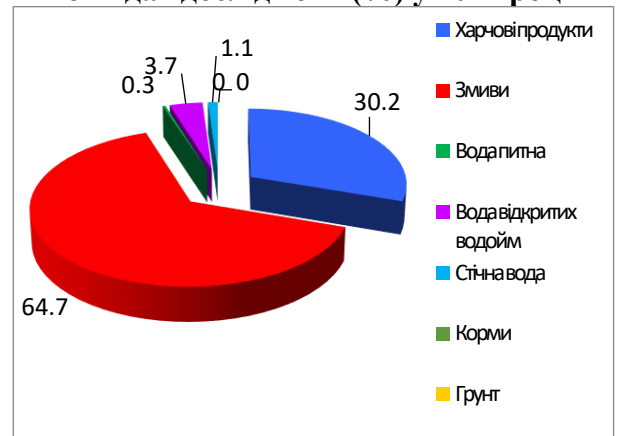
З ґрунту в 2024 році сальмонели не виділялись (2023 рік - 1 штам – 0,3%).

Діаграми 16,17.

Діаграма 16. Питома вага сальмонел, виділених з об'єктів СЖЛ в Україні по видах досліджень (%) у 2023 році



Діаграма 17. Питома вага сальмонел, виділених з об'єктів СЖЛ в Україні по видах досліджень (%) у 2024 році



До обласних центрів контролю та профілактики хвороб було надіслано на підтвердження із закладів охорони здоров'я 1019 культур сальмонел (2023 рік – 909). Не підтверджено 12 штамів, що становить 1,2% від усіх надісланих (2023 рік - 7 штамів – 0,8%), з них 5 культур (41,7%) не підтверджені за родовою належністю (2023 рік - 3 культури – 42,9%), що свідчить, що проблеми в лабораторній діагностиці залишаються, а тому потребують постійного аналізу, контролю як внутрішнього так і зовнішнього.

До ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» в 2024 році з регіонів надійшло 169 культур сальмонел (2023 рік - 120 культур). 3 них на підтвердження 132 культури (2023 рік – 109 культур), не підтверджено біовар 18 культур (2023 рік - 2 культури). На ідентифікацію було надіслано 37 культур.

Культури, які були виділені при розслідуванні спалахів, надіслано на підтвердження з 9 регіонів а саме: Хмельницької, Рівненської, Київської, Чернігівської, Запорізької, Черкаської, Чернівецької, Одеської, Харківської областей та м. Києва. Проте, не з усіх регіонів надсилалися культури сальмонел на підтвердження. В цілому з 20 спалахів сальмонельозу на підтвердження до ДУ «ЦГЗ МОЗ України» було надіслано 134 культури з 15 спалахів (2023 рік – 97 культур з 10 спалахів із 7 регіонів). 3 них 107 на підтвердження та 27 на ідентифікацію. **Важливо: штами сальмонел, які були виділені під час спалахів необхідно надсилати для підтвердження до ДУ «ЦГЗ МОЗ України».**

З загальної кількості спалахів, що зареєстровані в Україні в 2024 році, 12,5% спалахів, залишились не встановленої етіології (2023 рік - 10,5%), що свідчить про існування проблем в лабораторній діагностиці та вимагає вдосконалення систем епідеміологічного та лабораторного контролю інфекційних захворювань.

Нагадуємо, що культури, які надсилаються на підтвердження до ЦГЗ МОЗ України, мають супроводжуватися направленням та паспортом штаму.

В направленні необхідно обов'язково вказати ціль дослідження культури (підтвердження або ідентифікація), джерело та обставини при яких був виявлений даний збудник сальмонельозу (спалах, вогнище або інше). **В випадку спалаху, обов'язково вказати адресу та місце виникнення спалаху.**

У паспорті культури має бути зазначена культуральна, біохімічна та серологічна характеристики виявленого збудника та визначена антибіотикограма. В випадку відсутності повного набору аглютинуючих сироваток, культура надсилається до ДУ «ЦГЗ МОЗ України» на ідентифікацію, при цьому в паспорті штаму вказується результат аглютинації культури з кожною відповідною сироваткою, які є в наявності. Оптимальний набір сироваток для більшості сероварів сальмонел, що найчастіше зустрічаються в кожному конкретному регіоні, має бути в наявності як для щоденної роботи, так і на випадок спалаху. Нагадуємо, що ідентифікація виділених культур може бути якісною та достовірною лише при обов'язковому дотриманні методик досліджень, проведенні контролю якості відповідних диференціально-діагностичних поживних середовищ, дотриманні умов і термінів зберігання поживних середовищ та аглютинуючих сироваток.

Нагадуємо, що на підтвердження до ДУ «ЦГЗ МОЗ України» необхідно надсилати:

- штами S.Java, S.Paratyphi B та S.Typhi;**
- штами, які були виділені під час спалаху;**
- штами у яких утруднене серологічне типування;**
- штами стійкі до дезінфекційних засобів;**
- штами які мають множинну стійкість до антибіотиків;**
- сальмонели, що вперше або рідко зустрічаються на території регіону.**

Інформаційно-аналітична довідка про розповсюдженість сальмонел серед людей та в об'єктах середовища життєдіяльності людини на території України у 2024 році підготована на основі даних державної статистичної (ф.2) та галузевої звітності (ф. 40-здоров.)

Виконавці: Глушкевич Т.Г. ,
Ставська А.Л.